



STRATÉGIE ARGUMENTAIRE

Passage en catégorie B — Ambulanciers FPH

Note d'appui CGT / SUD · CHU de Toulouse · Version consolidée 29 juin 2026

Intègre : saisine ministérielle · module M7 SMUR · privatisation · plan zéro contention 2030 · PSL CHU Caen Normandie · AFASH 02/2026 · témoignage CHG marchant (sinistralité routière, abandon de protection)

Mise à jour du 26 juin 2026 — Extension module M3

Le module M3, initialement centré sur les soins palliatifs et la médecine nucléaire, est désormais élargi à l'ensemble des situations de fragilité clinique et de risque infectieux élevé : médecine infectieuse, aplasie médullaire, sorties de bloc et de réanimation, patients greffés.

Mise à jour du 26 juin 2026 — Impact du Plan « Zéro contention 2030 »

L'annonce du 2 juin 2026 par la ministre Stéphanie Rist d'un objectif national « zéro contention » en psychiatrie à l'horizon 2030 a une incidence directe sur le risque en transport, et renforce le contenu du module M1.

Mise à jour du 27 juin 2026 — Intégration du périmètre SMUR

Un nouveau module M7 « Spécificités ambulancier SMUR » est ajouté, couvrant les 10 compétences exercées au sein du trinôme SMUR sans cadre de formation ni reconnaissance RNCP (dossier AFASH version 02/2026). Comparatif international : Royaume-Uni (paramedic HCPC), Allemagne (Notfallsanitäter 3 ans), Québec, États-Unis.

Mise à jour du 28 juin 2026 — Saisine ministérielle et argument privatisation

La saisine adressée à la ministre Rist et au DGOS le 28 juin 2026 consolide l'ensemble des arguments. L'argument économique est enrichi : sous-traitance généralisée (surcoût T2A 30-50 %), perte de traçabilité clinique, vulnérabilité du service face aux grèves de prestataires privés (CHU Toulouse, expérience de blocage documentée).

Mise à jour du 29 juin 2026 — Transports de produits sanguins labiles (PSL)

L'exemple du CHU de Caen Normandie (ambulanciers internes effectuant des transports de PSL sans formation DEA reconnue) est intégré comme Axe 4 de l'argumentaire. Nouvelle référence réglementaire : arrêté du 10 septembre 2007 relatif aux bonnes pratiques transfusionnelles.

Mise à jour du 29 juin 2026 — Témoignage CHG marchant : sinistralité routière et abandon de protection institutionnelle

Intégration du témoignage d'une ambulancière du CHG marchant (Toulouse), victime d'une agression routière en juillet 2017, abandonnée par sa direction faute de suite pénale, contrainte à financer elle-même sa défense juridique (gain de cause mi-2024), 10 mois d'arrêt de travail et séquelles psychologiques durables. Cet exemple documente un mécanisme systémique d'abandon de protection sociale et renforce l'Axe 7 (sinistralité) ainsi que l'argument économique du turnover (Axe 6).

Expéditeurs : Intersyndicale CGT — SUD Santé Sociaux · CHU de Toulouse, Service Transport Patients · Julien TERRE (CGT) · Sébastien GOUSSY (CGT) · Victor ALAVA (SUD) · Laurent BEZIA (représentant du personnel ambulancier) · Jérôme JEAN-CHARLES (représentant du personnel ambulancier)

I. CONSTAT : UN DÉCROCHAGE DEVENU INTENABLE

Trois constats cumulatifs fondent la légitimité de la revendication catégorielle

— **Une grille salariale sous le SMIC pour les premiers échelons**, alors que le métier suppose un diplôme d'État de niveau 4 (DEA) et des responsabilités cliniques engageant directement la sécurité du patient.

— **Une profession laissée pour compte lors du Ségur de la santé 2020** : les aides-soignants et auxiliaires de puériculture — diplôme de même niveau 4 RNCP — sont passés de catégorie C à catégorie B au 1er octobre 2021 (décret n° 2021-1257). Les ambulanciers ont seulement été rattachés à la filière soignante par le décret n° 2022-1658,

sans changement de catégorie : une reconnaissance d'appellation, pas de statut.

— **Un référentiel DEA (arrêté du 11 avril 2022) qui ne couvre plus la réalité des missions exercées** : transports sous contrainte psychiatrique, transferts UMD/USIP, réintégrations après fugue, transports pénitentiaires (UHSI, UHSA), soins palliatifs, médecine nucléaire, risque infectieux élevé (médecine infectieuse, aplasie médullaire), sorties de bloc/réanimation, patients greffés, transports mortuaires nocturnes, Plans Blancs, **transports de produits sanguins labiles (PSL) sans cadre de formation reconnu**. Pour les ambulanciers SMUR : assistance aux gestes de réanimation, damage control préhospitalier, gestion de scène, mesures NRBC, coordination interservices (SDIS, Police, ARS), interventions hélicoptées HéliSMUR — toutes compétences sans cadre de formation ni reconnaissance RNCP.

C'est l'articulation de ces trois constats — sous-rémunération, exclusion du Ségur, écart missions/formation — qui doit structurer l'argumentaire, et non chacun isolément.

II. SEPT AXES ARGUMENTAIRES

Axe 1 — L'élargissement de fait des missions, au-delà du référentiel DEA 2022

Le référentiel DEA (5 blocs, arrêté du 11 avril 2022 modifié en 2024) couvre la prise en soin générale (bloc 1), les gestes d'urgence GSU2 — socle minimal non spécialisé (bloc 2) —, la conduite du véhicule sanitaire (bloc 3), l'entretien matériel (bloc 4) et le travail en équipe (bloc 5). Il ne couvre pas, ou de façon allusive :

— **Gestion de la contrainte et de l'agressivité** (transports psychiatriques sous contrainte, transports pénitentiaires sous escorte) — enjeu renforcé par le Plan « zéro contention 2030 ». À titre de comparaison, le référentiel DEAS mobilise des intervenants spécialisés (psychologue, formateur FGSU) que le DEA ne prévoit pas, alors même que les ambulanciers font face aux mêmes publics en vulnérabilité psychique.

— **Médecine de catastrophe et Plans Blancs** — pourtant requis pour pallier les déficits d'effectifs SAMU.

— **Patients fragiles et à risque infectieux élevé** : soins palliatifs, médecine nucléaire (radioprotection), médecine infectieuse, aplasie médullaire, sorties de bloc/réanimation, patients greffés — manipulation de dispositifs invasifs (drains, sondes, perfusions, PSE) sans formation dédiée.

— **Transports mortuaires nocturnes** — gestion relationnelle des familles en détresse, interventions isolées sans procédure formalisée.

— **Compétences SMUR** (ambulanciers au sein du trinôme médecin-infirmier-ambulancier) : assistance aux gestes de réanimation (aide à l'intubation, BAVU), damage control préhospitalier (garrots, pansements compressifs, priorisation hémorragie-ventilation), préparation de kits de perfusion pour l'IDE, gestion de scène complexe et mesures NRBC, intervention en SSE (ORSEC, plan rouge, tri/pré-tri), coordination SDIS/Police/ARS/SAMU, brancardage en milieux hostiles et HéliSMUR, débriefing post-intervention — **dix compétences sans aucune reconnaissance ni cadre RNCP** (dossier AFASH 02/2026).

— **Transport pédiatrique et néonatal spécialisé** (incubateurs, transferts avec équipe SMUR pédiatrique) : le bloc 2 du DEA (GSU2) reste un socle généraliste qui ne couvre pas les spécificités de la prise en charge pédiatrique — posologie pondérale, gestion de voies aériennes de petit diamètre, prévention de l'hypothermie du nourrisson. La FAE pédiatrique, bien que fortement recommandée pour ces transports à haut risque, demeure une formation optionnelle, non certifiante et hors RNCP, accessible de façon inégale selon les établissements.

— **Maintenance de premier niveau outillée** — évoquée dans la fiche de poste Direction sans qu'aucune formation DEA ne la couvre.

Argument-clé —

Un agent qui exerce des missions non couvertes par son référentiel engage sa responsabilité personnelle sans filet de compétence reconnu. C'est un argument de sécurité patient et de protection de l'agent — difficilement contournable par la Direction.

Axe 2 — Le précédent du Ségur : même niveau de diplôme, statut différencié

Critère	Aides-soignants (AS)	Ambulanciers FPH
Diplôme	DEAS — Niveau 4 RNCP	DEA — Niveau 4 RNCP
Durée de formation	1 540 h (770 h théorie + 770 h stage), 22 semaines chacune, ou 18 mois apprentissage	801 h (6 mois initial ou 12 mois alternance) + FAE SMUR optionnelle 175 h — non diplômante, hors RNCP
Actes élargis 2021-2024	Glycémie capillaire, SpO2, soins de stomie, pose sonde urinaire, ECG, aspiration trachéotomisée, pansements simples, nutrition entérale...	Paramètres vitaux complets, ECG 12 dériv., O2, VVP urgence (SMUR), aspiration VAS, RCP+DAE, surveillance dispositifs invasifs, isolement protecteur, bilan SAMU...

Filière FPH	Soignante — catégorie B depuis 01/10/2021	Soignante en droit (décret 2022-1658) — maintien de fait en filière technique/logistique dans de nombreux CHU : organigrammes, encadrement non soignant, absence d'intégration aux instances soignantes
Catégorie	B — décret 2021-1257 du 29/09/2021	C — aucune mesure catégorielle à ce jour

Groupe de travail ministériel VAE, 7 novembre 2025 : le niveau de compétences exigé pour le DEA « relève sans conteste de la catégorie B de la fonction publique » (Force Ouvrière). Le ministère reconnaît lui-même l'équivalence tout en maintenant les agents en catégorie C.

Argument-clé —

Il ne s'agit pas de revendiquer un privilège, mais de corriger une iniquité de traitement entre deux corps de diplôme et de niveau de risque comparables, l'un revalorisé en 2021, l'autre non. L'écart de durée de formation (DEA : 801 h vs DEAS : 1 540 h) joue en faveur de l'argumentaire : les AS bénéficient d'une formation deux fois plus longue, ce qui rend d'autant moins justifiable le maintien des ambulanciers en catégorie C.

Axe 3 — Le déficit de formation : l'angle d'attaque le plus difficile à réfuter

Paradoxalement, le point faible apparent (absence de formation aux missions réellement exercées) place la Direction devant un **choix binaire incontournable** :

- **Soit elle reconnaît** que ces missions relèvent d'un champ de compétences soignant élargi → ce qui justifie la révision du référentiel ET la révision catégorielle qui doit l'accompagner ;
- **Soit elle nie** cet élargissement de fait → mais alors elle doit retirer ces missions de la fiche de poste, ce que les organisations syndicales refusent.

Le dossier AFASH (version 02/2026) documente **12 compétences spécifiques exercées par l'ambulancier SMUR sans cadre de formation ni reconnaissance RNCP**, et recense sur l'ensemble des missions CHU, psychiatrie et SMUR **24 missions hors périmètre DEA/décret n° 2022-629 sur 32 recensées** (soit les trois quarts).

Comparatif international (AFASH 02/2026) : la France est le seul grand pays à ne disposer d'aucun positionnement RNCP spécifique pour l'ambulancier spécialisé en urgence préhospitalière. Royaume-Uni : paramedic reconnu par le HCPC. Allemagne : Notfallsanitäter, 3 ans de formation spécialisée. Québec : diplôme reconnu nationalement. États-Unis : paramedic certifié.

Axe 4 — Transports de produits sanguins labiles sans formation reconnue — Exemple du CHU de Caen Normandie

Les ambulanciers internes du CHU de Caen Normandie effectuent régulièrement des transports de **produits sanguins labiles (PSL)** — concentrés de globules rouges, plaquettes, plasma frais congelé — entre les établissements du territoire, en dehors de tout cadre de compétences reconnu au référentiel du DEA. Cet exemple illustre une lacune structurelle qui dépasse le seul CHU de Caen et concerne l'ensemble des établissements de la filière soignante. Quatre points précis fondent cet axe :

- **Exigences réglementaires de la chaîne du froid non couvertes** : l'arrêté du 10 septembre 2007 relatif aux bonnes pratiques transfusionnelles impose des conditions strictes par produit (température +2°C/+6°C pour les concentrés érythrocytaires, agitation continue pour les plaquettes, décongélation maîtrisée du PFC). Aucun bloc de compétences du DEA ne couvre ces exigences — les ambulanciers les exercent hors cadre formateur reconnu.
- **Traçabilité documentaire obligatoire sans délégation formalisée** : feuille de suivi, vérification des concordances groupe/rhésus/cross-match, bon de délivrance nominatif. En l'absence de cadre de délégation, la responsabilité de cette traçabilité incombe directement au transporteur.
- **Absence de protocole d'escalade en cas d'incident** : rupture de chaîne du froid, défaillance du container isotherme, délai anormal — aucun protocole défini dans la fiche de poste des ambulanciers ne prévoit la conduite à tenir ni la chaîne de signalement.
- **Aucun bloc de compétences du DEA ne couvre ces missions** : l'arrêté du 11 avril 2022 modifié le 4 juillet 2024 ne mentionne pas les exigences transfusionnelles. Les ambulanciers exercent donc ces missions en dehors de tout cadre formateur et réglementaire reconnu.

Argument-clé —

Un ambulancier qui assure un transport de PSL engage sa responsabilité personnelle et celle de l'établissement sans qu'aucun cadre de compétence ni de délégation formalisée ne l'y autorise. En cas d'incident transfusionnel imputable à un défaut de conditions de transport, la responsabilité civile et pénale de l'agent et de l'employeur peut être engagée sans que l'assurance professionnelle ne couvre une mission non référencée dans la formation initiale. C'est un argument de sécurité transfusionnelle et de protection juridique de l'agent — recevable devant la DGOS comme devant la HAS dans le cadre de la certification des établissements.

Constat intersyndicale 2026, CHU de Caen Normandie. — Arrêté du 11 avril 2022 relatif à la formation conduisant au DEA (modifié le 4 juillet 2024) : absence de bloc de compétences transfusionnelles. — Arrêté du 10 septembre 2007 relatif aux bonnes pratiques transfusionnelles.

Axe 5 — Plan « Zéro contention 2030 » : un risque déplacé vers le transport

L'annonce du 2 juin 2026 par la ministre Stéphanie Rist d'un objectif national « zéro contention » en psychiatrie à l'horizon 2030 produit un effet non documenté sur la phase de transport :

- La réduction programmée du recours à la contention mécanique — parfois utilisée pendant le transport faute d'alternative — **déplace mécaniquement une partie du risque comportemental vers la phase de transport** ;
- L'habitacle du véhicule est un espace confiné, mobile, dépourvu des moyens d'alerte disponibles en service hospitalier — gestion d'une crise comportementale structurellement plus risquée qu'en unité de soins ;
- Aucun des leviers annoncés (cartographie nationale, formation à la désescalade, espaces d'apaisement, programme Quality Rights OMS) ne vise à ce stade les professionnels du transport sanitaire.

Argument-clé —

Le Plan zéro contention 2030 ne réduit pas le risque pour l'ambulancier : il en déplace une partie vers le transport sans solution de substitution. Argument réglementaire national non contestable, à porter en priorité dans le protocole de fin de conflit et dans la saisine DGOS.

Axe 6 — Privatisation et argument économique : le calcul de gestionnaire

La privatisation croissante des transports hospitaliers touche directement à la performance économique des établissements et à la sécurité patient. Le passage en catégorie B doit être lu comme un **investissement en stabilité RH** face à un coût du statu quo qui dépasse largement celui de la revalorisation.

- **Sous-traitance généralisée** : les CHU externalisent de plus en plus les transports sanitaires vers des opérateurs privés (entreprises de transport sanitaire, sociétés d'intérim), sous la pression des difficultés de recrutement en personnel propre.
- **Surcoût direct (T2A)** : le recours à l'intérim coûte entre **30 et 50 % plus cher qu'un agent statutaire**, hors formation et intégration. Ce surcoût est supporté par le budget T2A de l'établissement.
- **Perte de traçabilité clinique** : les transports externalisés perdent la centralisation des données d'incidents, temps de transport et qualité de prise en charge — fragilise la gouvernance clinique, les indicateurs HAS/CPOM et la sécurité patient.
- **Vulnérabilité du service** : la dépendance aux prestataires expose aux grèves privées, ruptures de contrat et fluctuations de marché. **Le CHU de Toulouse a connu des blocages de transports lors de mouvements sociaux d'ambulanciers privés.**
- **Perte d'expertise terrain** : chaque départ et chaque recours à l'intérim détruit une connaissance des circuits internes, protocoles et spécificités des patients réguliers — non transférable à un prestataire externe.

Poste de coût — statu quo	Estimation documentée
Intérim paramédical (surcoût direct T2A)	30 à 50 % plus cher qu'un agent statutaire — pour 20 % des postes sur 50 agents : 90 000–150 000 €/an (FHF/ANAP 2025)
Turnover 18 % annuel	15 000 à 40 000 € par départ (recrutement, intégration, perte de productivité, formation) → 9 départs/an sur 50 agents : 135 000–360 000 €/an (Hoppi 2026 ; FNTS 2022)
Grèves et désorganisation	Heures supplémentaires non anticipées, surcharge agents présents, dégradation continuité de service, pénalités prestataires (CHU Toulouse, grève depuis le 7 juin 2026)
Perte de traçabilité (externalisation)	Risque de responsabilité juridique, impossibilité d'alimenter les indicateurs qualité HAS/CPOM
PASSAGE EN CATÉGORIE B — 50 agents	150 000 à 200 000 €/an toutes primes incluses → INFÉRIEUR au seul surcoût intérim pour 20 % des postes

Argument-clé —

Le coût du passage en B (150-200 k€/an) est inférieur au seul surcoût de l'intérim pour 20 % des postes (90-150 k€) et très largement inférieur au coût cumulé intérim + turnover 18 % + grèves. Ce calcul de gestionnaire ne peut être ignoré par le DGOS dans le cadre de la maîtrise des dépenses d'intérim paramédical encadrée par le décret de 2025, ni dans celui de la certification HAS et des indicateurs de sécurité patient liés à la traçabilité des transports.

Axe 7 — Sinistralité routière, abandon de protection institutionnelle et coût humain : le témoignage de terrain comme révélateur systémique

Le témoignage d'une ambulancière du CHG marchant (Toulouse), documenté dans le cadre de la présente stratégie, illustre un mécanisme systémique d'abandon de la protection sociale et de l'employeur à l'égard d'un agent victime d'agression en service. Il constitue un argument de poids complémentaire aux données chiffrées nationales et renforce

l'urgence d'une revalorisation catégorielle.

Faits : en juillet 2017, l'ambulancière est victime d'une agression routière suite à un dépassement. Le conducteur agresseur a volontairement coincé son genou contre un VSL alors qu'elle était sortie de son véhicule pour comprendre pourquoi elle était poursuivie. Résultat : ITT (3 jours / 3 %), 10 mois d'arrêt de travail, et séquelles psychologiques durant plusieurs années.

Abandon de protection : la direction du CHG marchant n'a apporté aucun soutien à l'agente, au motif que le procureur n'avait pas donné suite en pénal. L'établissement s'est désolidarisé de sa propre salariée, la laissant seule face à la procédure judiciaire et aux conséquences professionnelles et humaines de l'agression.

Coût personnel de la justice : contrainte de financer elle-même sa défense juridique, l'ambulancière a dû payer de sa poche un avocat. Elle n'a obtenu gain de cause qu'en mi-2024, soit sept ans après les faits, après un parcours judiciaire long et coûteux que sa catégorie salariale et sa grille indiciaire ne lui permettaient pas d'assumer sans sacrifice financier personnel.

Conséquences structurelles : ce témoignage n'est pas un cas isolé. Il révèle un pattern institutionnel où l'ambulancier, faute de reconnaissance statutaire et de catégorie à la hauteur du risque réel, est considéré comme un agent technique/logistique dont la vulnérabilité en service n'appelle pas la mobilisation des dispositifs de protection réservés aux personnels soignants. Le statut de catégorie C, avec une grille indiciaire sous le SMIC aux premiers échelons, place l'agent dans une situation de précarité qui l'empêche d'accéder aux moyens de défense juridique et médicale nécessaires.

Articulation avec les données nationales : ce témoignage individuel corrobore les statistiques documentées : accidentologie 2,5× supérieure à la moyenne des professions de santé (Sécurité Routière 2023); 57 à 93 % des ambulanciers victimes de violence sur carrière (rapport sécurité professionnels de santé 2025); 47 % d'épuisement professionnel déclaré (Observatoire QVT 2022). Il donne un visage humain à des chiffres qui, sans témoignage, restent abstraits pour la Direction et le DGOS.

Argument-clé — *Le témoignage du CHG marchant démontre que le risque ambulancier ne se limite pas aux missions cliniques ou à la contrainte psychiatrique : il inclut la sinistralité routière, l'agression par des tiers, et l'exposition à un environnement de travail hostile (espace public, conduite d'urgence, arrêts imprévus). La faible catégorie salariale empêche l'agent de se défendre juridiquement et l'expose à un abandon de protection par l'employeur. C'est un argument de justice sociale, de protection de l'agent et de responsabilité employeur — recevable devant la DGOS, la HAS, et la juridiction prud'homale. Le passage en catégorie B, en revalorisant l'indice et la reconnaissance statutaire, constitue un préalable à l'accès effectif aux droits de défense et de réparation des agents victimes de sinistralité en service.*

III. PROPOSITION OPÉRATIONNELLE — MODULE MHS

Bloc complémentaire au DEA · Format FAE SMUR (arrêté du 17 mai 2023)

La création d'un **Module Missions Hospitalières Spécifiques (MHS)** reprend le format déjà validé de la FAE SMUR (arrêté du 17 mai 2023) — immédiatement crédible auprès d'une Direction et d'une ARS, sans création ex nihilo. Il démontre, par construction, que les missions exercées dépassent le périmètre du DEA socle et constitue le support documentaire de la demande de révision catégorielle.

N°	Module	Contenu	Justification / Sources
M1	Transport sous contrainte et gestion de l'agressivité	Cadre légal contrainte (HSC, HDT), désescalade verbale renforcée en espace confiné SANS contention mécanique (trajectoire « zéro contention 2030 »), gestion du risque comportemental en habitacle, protocoles d'alerte, agressivité du patient détenu.	3 751 transports psychiatriques sous contrainte en 2025 · UHSI sous condition de formation · ambulanciers Hôpital Marchant (UMD/USIP, fugues) · Plan zéro contention 2030
M2	Transports sécurisés et pénitentiaires	Conduite sous escorte, protocoles IRIS, coordination Police Nationale, administration pénitentiaire ; transferts UHSI, UHSA, JLD, tribunaux.	Modèle CHU de Lyon · condition maintien mission UHSI · ambulanciers établissements psychiatriques (transferts détenus vers UHSA)
M3	Patients fragiles et à risque infectieux élevé	Radioprotection + accompagnement fin de vie (soins palliatifs, médecine nucléaire) ; isolement protecteur + asepsie renforcée (médecine infectieuse, aplasie médullaire) ; surveillance paramètres vitaux + manipulation dispositifs invasifs (drains, sondes, perfusions, PSE) pour sorties de bloc/réanimation ; vigilance signes de rejet (greffés).	Part significative des transports inter-services CHU · aucune formation dédiée à ce jour · MAJ 24/06/2026
M4	Transports mortuaires	Cadre réglementaire transport de corps, posture relationnelle face aux familles endeuillées, protocoles	Risque identifié : aucun agent ne devrait intervenir seul sans

		de sécurité pour interventions isolées hors heures ouvrables.	procédure définie
M5	Médecine de catastrophe et Plan Blanc	Organisation chaîne médicale des secours, gestes d'urgence renforcés, équivalence partielle tronc commun FAE SMUR, mobilisation en cas de déficit SAMU.	Équité revendiquée avec les ambulanciers SAMU pour intégration aux Plans Blancs
M6	Maintenance de premier niveau du matériel	Contrôles et dépannage simples avec outillage fourni, procédure de signalement pour le reste.	Condition syndicale explicite avant toute inscription en fiche de poste
M7	Spécificités ambulancier SMUR [NOUVEAU — 27/06/2026]	Au sein du trinôme SMUR (médecin–infirmier–ambulancier) : assistance gestes réanimation (aide intubation, pose dispositifs, BAVU) · damage control préhospitalier (garrots, pansements compressifs, priorisation hémorragie–ventilation) · préparation kits perfusion IDE · gestion scène complexe + mesures NRBC · SSE (ORSEC, plan rouge, tri/pré-tri sous supervision) · coordination interservices (SDIS, Police, ARS, SAMU) · brancardage milieux hostiles + HéliSMUR · maintenance/dépannage matériel UMH · populations vulnérables SMUR (pédiatrie, bariatrique, psychiatrie, personnes âgées) · débriefing structuré post-intervention.	Dossier AFASH 02/2026 · 12 compétences sans cadre RNCP · FAE SMUR (175 h) couvre partiellement · proposition AFASH : spécialisation post-DEA 5 mois / 600-700 h / niveau 4 RNCP · Question parlementaire Naegelen 28/05/2024

Focus module M3 — Double enjeu de sécurité (MAJ 24 juin 2026)

- — **Pour le patient** : dégradation clinique possible en cours de trajet, exigence d'asepsie stricte selon le statut immunitaire.
- — **Pour l'agent** : reconnaissance des signes d'alerte clinique, manipulation de dispositifs médicaux invasifs (drains, sondes, perfusions, oxygénothérapie, PSE) sans formation dédiée à ce jour.

Conséquence pour la négociation : cet élargissement doit être répercuté dans le chiffrage de l'écart de formation (axe 3) et dans les indicateurs à produire (section V).

Focus ambulanciers en établissement psychiatrique autonome (ex. Hôpital Marchant, Toulouse)

Les trois stages prévus par la formation DEA (médecine d'urgence, transport sanitaire, structures de soins) ne comportent aucun stage en établissement psychiatrique. Les ambulanciers internes de l'Hôpital Marchant exercent pourtant : consultations/hospitalisations somatiques de patients psychiatriques, transports inter-services sur le département (CMP, hôpitaux de jour, centres de post-cure), transferts vers UMD/USIP (patients en crise aiguë, parfois sur de longues distances), réintégrations après fugue, transferts de détenus vers l'UHSA, transports vers le juge des libertés et de la détention ou les tribunaux.

Argument-clé —

L'écart missions/référentiel ne se limite pas au CHU : il concerne l'ensemble des établissements de la filière soignante employant des ambulanciers, y compris les établissements psychiatriques autonomes. Cette extension permet d'associer les organisations syndicales de ces établissements à la démarche.

Focus ambulanciers SMUR — 24 missions sur 32 hors périmètre DEA (MAJ 27 juin 2026)

Le dossier AFASH (02/2026) documente que sur 32 missions recensées pour l'ambulancier CHU/psychiatrie/SMUR, **24 sortent du périmètre couvert par le DEA et le décret n° 2022-629** (soit les trois quarts). Les 10 domaines de compétences SMUR sont tous absents du DEA socle. La FAE SMUR (175 h, non certifiante, hors RNCP) n'en couvre qu'une partie.

Pays	Reconnaissance	Durée / Niveau
Royaume-Uni	Paramedic — reconnu par le HCPC (Health and Care Professions Council)	Formation universitaire 3 ans — Niveau licence
Allemagne	Notfallsanitäter — réforme 2014 (Notfallsanitättergesetz)	3 ans de formation spécialisée — Niveau bac+
Québec	Technicien ambulancier paramédic — diplôme reconnu nationalement	Formation collégiale 2 ans — Diplôme d'État
États-Unis	Paramedic — certifié NREMT (National Registry of EMTs)	Formation post-EMT spécialisée — Certification nationale
France	Aucun positionnement RNCP spécifique pour l'ambulancier SMUR	FAE SMUR 175 h — non diplômante, hors RNCP

Focus ambulanciers en établissement CHU — CHU de Montpellier

Au CHU de Montpellier, comme à Toulouse, les ambulanciers sont rattachés au pôle transport et logistique, ce qui constitue l'une des revendications locales à faire reconnaître. Pourtant, leurs missions dépassent largement ce cadre : outre les transports pénitentiaires, les réintégrations et certaines missions SAMU déléguées non tracées volontairement, ils assurent des **transports de couveuses pédiatriques avec l'équipe du SMUR pédiatrique**, nécessitant une vigilance spécifique et une **FAE pédiatrique fortement conseillée**, ajoutant 2 jours de formation. Cette formation reste cependant facultative, non certifiante et hors RNCP : aucun module pédiatrique n'est intégré au socle DEA, alors que la prise en charge de nourrissons à risque, de plus aucune formation au cours du DEA couvre une formation sur la psychologie infantile pendant le stress d'un transfert pédiatrique vers un bloc opératoire vis à vis de l'enfant et de ses parents — posologie pondérale, voies aériennes réduites, thermorégulation — exige une technicité spécifique que le référentiel généraliste ne prévoit pas. Ils réalisent également des **prises en soin bariatriques** avec équipement spécifique adapté aux patients en surpoids ou lourdement appareillés par des dispositifs de soins. Ces activités renforcent l'écart entre le référentiel DEA et la réalité du terrain, et confirment l'élargissement de fait des missions exercées.

IV. PLAN D'ACTION ET SÉQUENCEMENT DE LA NÉGOCIATION

Échéance	Action	Objectif
Court terme (protocole de fin de conflit)	Reconnaissance écrite de l'écart missions/référentiel (M3 élargi + ambulanciers psychiatrie + SMUR + PSL CHU Caen) · engagement à créer le module MHS avec volet désescalade anticipant le Plan zéro contention 2030 · NBI/IFR ou équivalent en mesure transitoire · désignation d'un cadre de santé référent	Sécuriser des gains immédiats sans attendre la révision statutaire nationale
3–6 mois	Construire avec la Direction des Soins et la Direction Formation le contenu détaillé du module MHS · documenter et chiffrer l'écart (heures de formation manquantes, nombre d'agents, sinistralité/incidents) · intégrer les données du périmètre SMUR (dossier AFASH 02/2026) et les transports PSL (CHU Caen Normandie) · intégrer le témoignage CHG marchant dans la documentation sinistralité	Dossier technique solide co-construit, non réfutable comme simple revendication catégorielle
6–12 mois	Porter le dossier via les fédérations CGT/SUD Santé Sociaux au niveau national · mutualiser avec les CHU mobilisés (Angers, Tours, Lyon, Marseille) · saisine DGOS sur la révision du décret n° 2022-1658	Peser sur la DGOS pour une révision du statut particulier du corps (modèle décret 2021-1257 pour les AS)
Au-delà	Mobiliser le rapport de force inter-CHU lors des prochaines négociations salariales FPH (clause de revoyure, conférence sociale nationale)	Inscrire la revendication dans un calendrier national — seul niveau pertinent pour un changement de catégorie statutaire

V. ARGUMENTAIRE CHIFFRÉ — DONNÉES CHU DE TOULOUSE, ACTIVITÉ 2025

Indicateur	Volume 2025	Portée argumentaire
Total des transports patients	56 843	Démontre le caractère structurel, non marginal, de l'activité
Transports psychiatriques sous contrainte	3 751	Réfute le terme « ponctuel » utilisé dans le projet de fiche de poste
Transports urgences	4 033	Justifie le besoin de formation aux gestes d'urgence renforcés
À compléter : transports UHSI, mortuaires nocturnes, soins palliatifs/médecine nucléaire	→ à produire	Renforce les modules M2, M4, M3
À compléter : médecine infectieuse, aplasie médullaire, sorties de bloc/réanimation, greffés	→ à produire	Module M3 élargi — MAJ 24/06/2026
À compléter : transports PSL (CHU Caen Normandie et autres établissements)	→ à produire	Axe 4 — responsabilité civile et pénale, certification HAS
À compléter : sinistralité (agressions, accidents, incidents dispositifs médicaux)	→ à produire	ARGUMENT MAJEUR pour le DGOS — cf. données ONVS 2025 (90 victimes 2023, 85 en 2024) · témoignage CHG marchant (Axe 7)
À compléter (Hôpital Marchant) : transferts UMD/USIP, réintégrations fugue, détenus UHSA, transports JLD	→ à produire	Extension établissements psychiatriques autonomes
Témoignage CHG marchant — agression routière 2017	1 cas documenté (10 mois AT, séquelles psychologiques)	Axe 7 — sinistralité routière et abandon de protection institutionnelle comme révélateur systémique

	<i>durables, abandon direction, coût juridique personnel)</i>	
Turnover annuel CHU Toulouse	18 % (9 départs sur 50 agents)	Axe 6 — coût du statu quo supérieur au passage en B
Coût intérim 20 % des postes	90 000–150 000 €/an	Axe 6 — surcoût T2A direct

Données nationales de référence : ~2 500 ambulanciers en FPH (sénatrice Laurence Cohen, juin 2023) · 4 490 projets de recrutement nationaux (BMO France Travail 2026) · turnover 18 % annuel (FNTS 2022) · 78 % des entreprises en difficulté de recrutement (FNTS 2024) · 47 % d'épuisement professionnel déclaré (Observatoire QVT 2022) · accidentologie 2,5× supérieure à la moyenne des professions de santé (Sécurité Routière 2023) · 57 à 93 % des ambulanciers victimes de violence sur carrière (rapport sécurité professionnels de santé 2025).

VI. ANTICIPER LES OBJECTIONS DE LA DIRECTION

Objection probable	Réponse à apporter
« Le statut a déjà été revu en 2022 (décret n° 2022-1658) »	Ce décret a changé le rattachement de filière (technique → soignante) mais pas la catégorie (toujours C). Incohérence dénoncée : reconnaissance d'appellation sans reconnaissance statutaire. De plus, dans de nombreux CHU, le rattachement formel à la filière soignante reste lettre morte (organigrammes logistiques, encadrement non soignant).
« Le passage en B relève du DGOS, pas de l'établissement »	Exact — la stratégie distingue les leviers locaux immédiats (protocole de fin de conflit, NBI/IFR, module MHS) des leviers nationaux à porter via les fédérations. Le CHU peut s'engager formellement à soutenir la demande auprès de la DGOS.
« Créer un module de formation a un coût et un délai »	Le format proposé reprend celui, déjà validé, de la FAE SMUR (arrêté du 17 mai 2023) : pas de création ex nihilo, déclinaison d'un dispositif reconnu par les CESU.
« Les autres CHU n'ont pas ce statut non plus »	Argument pour une mobilisation inter-établissements (Angers, Tours, Lyon, Marseille déjà mobilisés) — la comparaison doit jouer en faveur d'une dynamique collective, pas comme fin de non-recevoir.
« Le module M3 est trop large »	Le point commun n'est pas la spécialité médicale mais le niveau de risque clinique et le besoin de compétences absent du DEA (asepsie renforcée, dispositifs invasifs, signes d'alerte). La largeur reflète l'ampleur réelle des transports inter-services en CHU universitaire.
« Le Plan zéro contention 2030 va réduire les risques »	Le plan réduit le risque pendant l'hospitalisation, mais déplace une partie du risque comportemental vers le transport, sans solution de substitution ni formation dédiée pour les ambulanciers.
« Les transports PSL, ce n'est qu'un cas isolé »	Le CHU de Caen Normandie est un exemple documenté, non un cas unique. La lacune est structurelle : aucun CHU dont les ambulanciers transportent des PSL ne dispose d'un cadre formatrice reconnu au DEA. La responsabilité civile et pénale de l'employeur est engagée de la même façon partout.
« C'est une charge budgétaire supplémentaire »	C'est un investissement en stabilité RH. Coût du passage en B (150-200 k€/an) < surcoût intérim 20 % des postes (90-150 k€) + turnover 18 % (135-360 k€) + grèves. Argument économique renforcé par le risque de perte de traçabilité clinique et la fragilisation de la certification HAS.
“ L'agression du CHG marchant est un fait divers, pas un argument statutaire ”	Ce témoignage n'est pas un fait divers mais un révélateur systémique : l'absence de soutien de la direction, le coût juridique personnel, la précarité indiciaire empêchant l'accès à la défense, et les séquelles durables (10 mois AT, fragilité psychologique) illustrent la conséquence concrète du maintien en catégorie C. La sinistralité routière est un risque professionnel structurel (accidentologie 2,5× supérieure à la moyenne) que la catégorie actuelle ne couvre ni ne protège.

VII. SYNTHÈSE EN UNE PHRASE

Le passage en catégorie B ne doit pas être présenté comme une revendication salariale isolée, mais comme la conséquence logique et déjà actée par les pouvoirs publics pour un corps comparable (les AS), rendue d'autant plus nécessaire que les missions réellement exercées par les ambulanciers du CHU de Toulouse — documentées via le module M3 élargi (patients à risque infectieux élevé, sorties de bloc et de réanimation, patients greffés), le module M7 (spécificités SMUR : assistance aux gestes de réanimation, damage control préhospitalier, gestion de scène et coordination en SSE, interventions HéliSMUR) et l'Axe 4 (transports de PSL sans formation reconnue — CHU Caen Normandie, responsabilité civile et pénale engagée hors cadre DEA) et l'Axe 7 (témoignage CHG marchant : agression routière, 10 mois d'arrêt de travail, abandon de protection par la direction, coût juridique personnel, séquelles psychologiques durables — révélateur d'une

sinistralité non couverte par le statut actuel) — dépassent largement le périmètre couvert par leur diplôme d'État ; dépassement que confirme et aggrave le dossier AFASH (02/2026), qui documente 24 missions sur 32 hors périmètre DEA et 10 compétences SMUR sans aucune reconnaissance ni cadre RNCP, à rebours des modèles britannique, allemand, québécois et américain ; écart que le module MHS (M1 à M7) a précisément pour fonction de documenter, corriger et porter au niveau ministériel — et dont le coût du non-changement (intérim, turnover, grèves, perte de traçabilité, sinistralité non protégée) dépasse structurellement le coût du passage en catégorie B.

Références réglementaires clés : Décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022 · Décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 · Arrêté DEA du 11 avril 2022 modifié le 4 juillet 2024 · Arrêté FAE SMUR du 17 mai 2023 · Décret AMU n° 2022-629 · Art. L. 4393-1 et R. 6311-17 CSP · Plan « Zéro contention 2030 » (annonce du 2 juin 2026) · GT VAE ambulanciers (7 novembre 2025) · Dossier AFASH version 02/2026 · Question parlementaire Naegelen (28 mai 2024) · ONVS Rapport 2025 · BMO France Travail 2026 · FNTS 2024 · FHF/ANAP 2025 · Hoppi 2026 · **Arrêté du 10 septembre 2007 relatif aux bonnes pratiques transfusionnelles** · **Constat intersyndicale CHU Caen Normandie 2026** · **Témoignage ambulancière CHG marchant, juin 2026 (agression routière juillet 2017, 10 mois AT, séquelles psychologiques).**

Signataires : Julien TERRE (CGT) · Sébastien GOUSSY (CGT) · Victor ALAVA (SUD) · Laurent BEZIA (représentant du personnel ambulancier) · Jérôme JEAN-CHARLES (représentant du personnel ambulancier) — CHU de Toulouse, Service Transport Patients, Place du Docteur Baylac, TSA 40031, 31059 Toulouse Cedex 9